Station 1

Solveig 42 år, tidigare frisk, kommer till hälsocentralen då hon har rikliga menstruationsblödningar. Hon byter mensskydd varannan timme och blöder ibland igenom trots dubbla mensskydd. Blödningarna är regelbundna, 6-8 dagar var 28-31:e dag, inga mellanblödningar.

Du ska:

- **Utföra en adekvat gynekologisk undersökning.** Berätta högt vad du gör.
- **Informera patienten om dina undersökningsfynd**
- **Föreslå fortsatt handläggning**

Station 1 Ob/Gyn -Gynekologisk undersökning Solveig, 24/04/2024 SKARP 6 min Candidate:

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studenten ställer in ljuskällan och höjd på gyn-stol korrekt	1	0.5	0
Studenten för in undersökningsinstrumenten på ett adekvat sätt	2	1	0
Studenten rapporterar normala fynd i vulva, vagina och portio/cervix	1	0.5	0
Studenten genomför palpation av lilla bäckenet på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Studenten rapporterar att uterus är förstorad	1	- NA -	0
Studenten rapporterar att sidor är fria dvs inga förstorade adnexa	1	- NA -	0
Studenten genomför den gynekologiska undersökningen adekvat utifrån hygienaspekter = ren undersökningsteknik	1	0.5	0
Studenten rekommenderar två behandlingsåtgärder (1. tranexansyra, 2. järnstatus med ev järnsubstitution, 3. hormonspiral eller annan gestagen behandling är korrekt. Kombinerade P-piller är fel mtp ålder.)	2	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 3

Du jobbar som läkare och blir kallad till akutmottagningen. Ambulansen har kommit in med ett 13-årigt barn som har andningssvårigheter, klåda och har kräkts flera gånger. Detta hände ett par minuter efter han fått i sig en halv chokladbit med innehåll av jordnötter (Snickers). Barnet hostar, låter hest och är tydligt andningspåverkat. Det finns en sjuksköterska inne på rummet som fått rapport från ambulanspersonalen.

Du ska:

- **Bemöta och handlägga patienten**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Identifierar att det rör sig om anafylaxi (1 p)	1	- NA -	0
Undersöker barnet strukturerat (ABCDE) (1 p)	1	- NA -	0
Ordinerar Adrenalin i rätt dos (Adrenalin 1 mg/ml, 0,3 mg-0,5) (1 p)	1	- NA -	0
Ordinerar att adrenalinet ges intramuskulärt (1 p)	1	- NA -	0
Ordinerar intravenös nål + vätska (1 p)	1	- NA -	0
Ordinerar syrgas (1 p)	1	- NA -	0
Ordinerar luftrörsvidgande och/eller kortisoninhalation (1p)	1	- NA -	0
Ordinerar steroidpreparat och antihistamin (1 p)	1	- NA -	0
1. Kommunikationen och ordinationerna är tydliga (ssk bedömning) (2 - 1 p – 0 p)	2	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 4

Du kallas till akutrummet på medicinakuten där en 60-årig man inkommit med ambulans efter att ha svimmat under besök på stadens bibliotek. Ambulanspersonalen meddelar att allmäntillståndet är påverkat, och man önskar din hjälp. Det finns en sköterska med dig inne på rummet.

Du ska:

- **Ta anamnes**
- **Föreslå fortsatt utredning och behandling**

Station 4 Kardiologi - Svimning, 24/04/2024 SKARP 6 min **Candidate:**

	3p	2p	1p	0p
Ta en rimlig anamnes som ska innehålla aktuell sjukdom (tidigare infarkt) och aktuella symptom (ej bröstsmärta)	- NA -	2	1	0
efterfråga ett blodtryck	- NA -	- NA -	1	0
efterfråga EKG och tolka det korrekt 0-1-2 p (regelbunden bred-QRS takykardi 1p; VT 1 p)	- NA -	2	1	0
kalla på narkosläkare, planera för sövning och beakta risk för aspiration (senaste födointag?) Fråga; vad vill narkosen veta?	- NA -	2	1	0
handläggning: närvarande, titta figuranten i ögon, lugna situationen, samtidigt planera för omedelbar sövning med el-konvertering (alternativt iv Cordarone) • 1p: informera • 1p: god kontakt med pat (figurant) • 1p: ordinera DC alt Cordarone	3	2	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 5

Du är underläkare på kirurgkliniken och ska genomföra morgonrond för en 30-årig patient som kört omkull med snöskoter och slagit sig mot en stubbe för 2 dagar sedan. Det gjordes då en trauma-DT (datortomografi). Patienten skrevs in för klinisk observation. Det planeras hemgång i dag om inga komplikationer tillkommit. På ronden har du med dig en sjuksköterska.

Du kan läsa patientens journal redan nu om du vill och en kopia finns vid patienten.

Du ska:

- **Genomföra rond tillsammans med patient och sjuksköterska**

Station 5 Kirurgi - skoterolycka, 24/04/2024 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Sammanfattar vad som är gjort och det som framkommer i journalen	1	0.5	0
Bildar sig en egen uppfattning av situationen genom frågor till ssk.	1	0.5	0
Bildar sig en egen uppfattning av situationen genom frågor till patient.	1	0.5	0
Bildar sig en egen uppfattning av situationen genom att göra bukstatus (minst palpation) och auskultera lungorna.	2	1	0
Drar slutsatser och redogör för misstanke om ytterligare komplikation (1p). Om misstanke om pneumothorax nämns ges 2p.	2	1	0
Förklarar och att nya rtg undersökningar kommer att göras akut, DT thx, DT thx/buk eller lungrtg.	1	- NA -	0
Förklarar att överläkare ska konsulteras.	1	- NA -	0
Nämner att det kan bli aktuellt med ett thoraxdränage med sug.	1	- NA -	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 6

En 65-årig kvinna kommer med ambulans till ett akutrum på Norrlands universitetssjukhus då hon för 35 minuter sedan haft ryckningar i armar och ben och sedan dess varit medvetslös. Hon har epilepsi efter en stroke förra året, men är i övrigt väsentligen frisk.

ABC är kontrollerat av din kollega som är narkosläkare, som berättar att patienten har fria luftvägar och normal andningsfrekvens. Akutsköterskan, som är inne på rummet har kontrollerat blodtrycket som är 155/85 mmHg, puls 67 /minut. Normalt B-glukos.

Du ska:

- **Kontrollera vakenhetsgrad och nervstatus.** Berätta högt vad du gör.
- **Informera sköterska om vidare åtgärder och fortsatt akut handläggning**

Vakenhet	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Tilltalar, hörjer rösten och ruskar om patienten (1-0,5-0 poäng)	1	0.5	0
Smärtstimulerar (0,5 poäng)	0.5	- NA -	0
Anger korrekt RLS (3) (1 poäng)	1	- NA -	0
Nervstatus	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Går vidare enligt APÖR och börjar kontrollera någon/några av de ingående delarna i APÖR (1,0-0,5-0 poäng)	1	0.5	0

Bedömning:	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Identifierar att det är ett status epilepticus (1 poäng)	1	0
Behandling:	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Korrekt preparat (Ativan/lorazepam, Sesolid/diazepam, Dormicum/midazolam) (1 poäng)	1	0
Korrekt administrationsväg (Ativan/lorazepam i.v., Stesolid/diazepam i.v., Dormicum/midazolam i.m. (0,5 poäng)	0.5	0
Korrekt dos (Ativan/lorazepam 2-4 mg., Stesolid/diazepam 5-10 mg, Dormicum/midazolam 5-10 mg (1 poäng)	1	0
Bra kommunikation med sjuksköterska (0,5 poäng)	0.5	0
Korrekt andra linjens behandling (Något av: Pro-Epanutin/Fosfenytoin, Ergenyl/Valproat, Levetiracetam/Keppra) (1 poäng)	1	0
Korrekt ungefärlig dos och administrationsväg (Något av: Pro-Epanutin/Fosfenytoin 15-25 mgFE/kg i.v., Ergenyl/Valproat 20-40 mg/kg i.v., Levetiracetam/Keppra 20-60 mg/kg i.v.) (0,5 poäng)	0.5	0
Anger sövning på IVA vid fortsatta kramper (1 poäng)	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 7

Du är underläkare på en geriatrisk avdelning. På röntgenronden har du nyss fått se bilder på tre av patienterna som vårdas på avdelningen.

Inför avdelningsronden vill ansvarig sjuksköterska att du ska visa och förklara vad man ser på bilderna.

Du ska:

- **Bedöma tre olika röntgenundersökningar**
- **Välja ett av föreslagna diagnosalternativ till varje undersökning**
- **Visa och förklara för sjuksköterskan:**
    - **Röntgenfyndet/fynden**
    - **Motivera diagnosen som du har valt**

Fall 1	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Valt diagnosalternativ Superscan med upptag i patologisk femurfraktur	1	- NA -	0
Demonstration **Peka ut fynd/fynden + ange korrekt lokalisation:** Demonstrerar fokalt upptag i femurfraktur samt diffust ökat upptag generellt (1p) Demonstrerar endast fokalt upptag i femurfraktur el diffust ökat upptag generellt (0,5 p)	1	0.5	0
Demonstration **Motiverar diagnosen:** Nämner att superscan tyder på generell skelettmetastasering och att upptag i frakturen kan bero på läkning eller metastas (patologisk fraktur) (1 p) Nämner endast att superscan tyder på generell skelettmetastasering eller att upptag i frakturen kan bero på läkning eller metastas (patologisk fraktur) (0,5 p)	1	0.5	0
Fall 2	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Valt diagnosalternativ Subtrochantär femurfraktur med intermediärfragment	1	- NA -	0
Demonstration **Peka ut fynd/fynden + ange korrekt lokalisation:** Anger minst 2 av nedanstående (1p). Anger 1 av nedanstående (0,5p) • Komminut fraktur/splittrad fraktur. • Subtrochantär femurfraktur. • Trochanter minor avlöst i ett intermediärfragment. • Kraftig förkortning och vinkelfelställning.	1	0.5	0
Demonstration **Motiverar diagnosen:** Förklarar och visar att minst 2 av nedanstående gäller (1p). Förklarar och visar att 1 av nedanstående gäller (0,5p) • trochanter major är inte involverad i frakturen, därför subtrochantär • trochanter minor är avlöst - påverkar inte klassificeringen • för nära trochanterområdet för att klassificeras som diafysfraktur. • collum femoris inte alls involverad i frakturen. • Klassifikation enligt Sensheimer: IV = Fyrfragmentfraktur eller flera fragment, inkl. trochanter minor).	1	0.5	0
Fall 3	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Valt diagnosalternativ Kroniskt subduralhematom	1	- NA -	0
Demonstration **Peka ut fynd/fynden + ange korrekt lokalisation:** Visar subdalhematomets utbredning (hela konvexiteten), sida, visar medellinjeöverskjutning och kompression av sidoventrikeln (1 p) Anger delar av ovanstående (0,5p)	1	0.5	0
Demonstration **Motiverar diagnosen:** Förklarar och visar att minst 2 av nedanstående gäller (1p). Förklarar och visar att 1 av nedanstående gäller (0,5p) • blödningen är huvudsakligen lågattenuerande, dvs ej färsk • detta inte är ett epiduralhematom (utbredning/attenuering + klinik) • det finns inslag av färskt blod sannolikt pga. det senaste fallet. • patienten har fallit x flera och ådragit sig ett kroniskt subduralhematom som över tid blivit större. • äldre kan få stora SDH med rel. lite symptom pga. atrofi	1	0.5	0
Professionell kommunikation	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Kommunikationsförmåga Tydlig, korrekt och professionell i alla avseenden inkl. korrekta fynd etc. (1p) Något svårbegriplig men hjälpligt, i stort sett korrekt och professionellt (0,5p) Stora svårigheter att kommunicera professionellt och visar och förklarar helt felaktigt (0p)	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 9

Du är AT-läkare på en hälsocentral och träffar för första gången en pigg och vital 80-årig patient som nyligen insjuknat i polymyalgia reumatika (PMR). Under konsultationen framkommer att patienten har tilltagande värk och stelhet i axlar, höfter och sätesmuskulatur sedan en månad. Du hittar vid klinisk undersökning stelhet och ömhet vid rörelser i axlar och höftleder, samt ömhet över trokanter major och tuber ischiadicum. I blodprover tagna inför besöket noterar du inflammation med B-SR 48 mm (referens < 30) och P-CRP 39 mg/L (referens < 3), men övriga prover är utan anmärkning. Patienten tycker sig förutom värken och stelheten må bra, och du misstänker ingen annan sjukdom än PMR.

Du ska:

- **Informera patienten om diagnosen**
- **Komplettera anamnesen avseende sjukdomens allvarlighetsgrad och inför fortsatt behandling**
- **Föreslå och informera om lämplig behandling**

Status förutom värk och stelhet är normalt och patienten behöver ej undersökas.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Empatiskt förhållningssätt	1	0.5	0
Frågar om diabetes eller nedsatt glukosintolerans, sömnstörning eller psykisk sjukdom, samt om osteoporos eller tidigare fraktur (2 områden ger full poäng)	2	1	0
Frågar om symptom på temporalisarterit (ögonsymtom, huvudvärk, tuggclaudcatio, ömhet i hårbotten), (minst 2 symtom för full poäng)	2	1	0
Ger aktivt patienten chans att ställa frågor	1	0.5	0
Förklarar vad PMR är, medicinskt korrekt och begripligt	2	1	0
Föreslår prednisolon 12,5-25 mg	1	0.5	0
Anger korrekt tid (någon-några dagar) till behandlingssvar	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 10

Du är underläkare på en hälsocentral. Idag har du sytt en mindre sårskada i pannan på denna patient. Medan sköterskan sätter på plåster läser du i journalen att patienten tidigare sökt både hälsocentral och akuten med blåmärken och sårskador och vid ett tillfälle skada mot ena ögat. Du vill nu prata med patienten för att förstå bakgrunden till dessa upprepade skador som du misstänker beror på våld.

Du ska:

- **Prata med patienten om de upprepade skadorna**
- **Föreslå adekvata åtgärder**

Det ingår ingen fysisk undersökning i denna konsultation.

Station 10 PU - Våld i nära relation, 24/04/2024 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar upp frågan om våld i nära relationer på ett tillfredsställande sätt	1	- NA -	0
Frågar efter förekomst av fysiskt våld	1	- NA -	0
Frågar efter förekomst av psykiskt våld	1	- NA -	0
Frågar efter förekomst av sexuellt våld	1	- NA -	0
Uppmärksammar (0,5p) och hanterar (0,5p) patientens skam på ett tillfredsställande sätt	1	0.5	0
Frågar om det finns några minderåriga barn som blivit utsatta för (0,5p) eller bevittnat våld (0,5p)	1	0.5	0
Förklara att hen blivit utsatt för brott/Fråga om hen har/önskar polisanmäla	1	- NA -	0
Föreslår adekvat åtgärd: hänvisa till stödfunktioner tex mans/kvinnofridsmottagningen, återbesök	1	- NA -	0
Besvarar fråga angående anmälan korrekt (dvs finns ej grund för läkare att anmäla vare sig till polis eller socialtjänst)	1	- NA -	0
Konsultationen genomsyras av respekt, att patienten blir lyssnad på och tagen på allvar (delvis 0,5p, helt 1p)	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 11

En 70-årig kvinna kommer till dig på vårdcentralen efter att ha varit hos optikern. Patienten fick inte några glasögon, utan fick höra från optikern att det skulle skickas en remiss till ögonklinik.

Du ska:

- **Testa visus enligt optikerns refraktionering.** Berätta högt vad du gör.
- **Informera patienten om vilket refraktionsfel hon har**
- **Föreslå ytterligare undersökning du vill göra på vårdcentralen**
- **Informera patienten om mest trolig diagnos**

Station 11 Ögon **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Sätter in korrekt glas på korrekt sätt - 1+1p	2	1	0
Talar om vad pat har för refraktionsfel - 1+1p	2	1	0
Identifierar läsaddition - 1p	1	- NA -	0
Föreslår kompletterande undersökning på vårdcentral - 1p	1	- NA -	0
Ställer rätt diagnos - 1p	1	- NA -	0
Förklarar optikerns handlande - 2p	2	- NA -	0
Förklarar att man får inte köra bil med visus 0,3 på båda ögonen - 1p	1	- NA -	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 12

Du har träffat Sture, 67 år på akutmottagningen. Han har lungcancer med spridning till lunga och lever och behandlas med cytostatika i kombination med immunterapi i första linjen. Utvärdering efter två kurer visar mycket god respons. Han söker nu med ett knappt dygns anamnes på feber, hosta och andfåddhet, tio dagar efter sin fjärde kur.

Status:
Allmäntillstånd: Saturation 92% på luft. Temperatur 39,2 °C.
Pulm: Rassel basalt bilateralt.
Blodtryck 110/60 mmHg.

Blodprover (referensvärden):
B-Hb 82 g/L (134-170)
B-LPK 0,7 · 10^9/L (3,5-8,8)
B-TPK 123 · 10^9/L (145-348)
P-CRP 22 mg/L (<3)
Vätske- och lever/gallstatus är normala.
Ytterligare provtagning är ej genomförd.

Du bestämmer dig för att lägga in Sture på avdelningen.

Du ska:

- **Rapportera patienten till sjuksköterskan på avdelningen**
- **Ordinera åtgärder och behandlingar för det kommande dygnet**

	3p	2p	1p	0p
Studenten rapporterar patienten strukturerat enligt SBAR	3	2	1	0

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studenten ordinerar rundodling (1,0,5 eller 0 p)	1	0.5	0
Studenten ordinerar adekvat iv antibiotika (1,0,5 eller 0 p)	1	0.5	0
Studenten ordinerar adekvat iv vätska (1,0,5 eller 0 p)	1	0.5	0
Studenten ordinerar blod (1,0p)	1	- NA -	0
Studenten ordinerar lungröntgen eller DT thx (1,0p)	1	- NA -	0
Studenten ordinerar kontroller (1,0,5 eller 0 p)	1	0.5	0
Studenten sätter en adekvat vårdnivå (1,0p)	1	- NA -	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 14

Din nästa patient på hälsocentralen är 84 år och kommer för högt blodtryck.

Patienten har även typ 2 diabetes med diabetesnefropati och tidigare hjärtinfarkt. Enligt distriktssköterskan har patienten också en minnessvikt, är nedstämd, har nykturi och har sista tiden ramlat ofta i hemmet på nätterna.

Patienten är mycket skeptisk till sina läkemedel, tycker de är rävgift, vill inte ta dem och har svårt att komma ihåg dem.

Blodtryck 165/98 mmHg, puls 53 /minut, BMI 19 kg/m^2

Provsvar (referens):

eGFR 52 ml/min/1,72m^2 (>60)
P-Natrium 132 mmol/L (137-145)
P-Kalium 4,5 mmol/L (3,5-4,6)
B-HbA1c 49 mmol/mol (31-46)

En läkemedelslista finns inne på rummet.

Du ska:

- **Ta en riktad anamnes**
- **Ta ställning till läkemedelsbehandlingen och patientens önskemål om färre läkemedel**
- **Underlätta god följsamhet till läkemedelsbehandlingen**

Status ingår INTE i uppgiften.

Station 14 Internmed - Hypertoni, 24/04/2024 SKARP 6 min **Candidate:**

	3p	2p	1p	0p
Kommunikation	- NA -	- NA -	1	0
Tar ställning till läkemedelsbehandling för hypertoni	3	2	1	0
Tar ställning till lämedelsbehandling för diabetes	- NA -	2	1	0
Tar ställning till övrig läkemedelsbehandling	3	2	1	0
Resonerar med patienten om hur läkemedelsbehandlingen kan underlättas	- NA -	- NA -	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 15

Din nästa patient på akutmottagningen är en 35-åring som söker för kräkning och diarré.

Du ska:

- **Ta anamnes med fokus på aktuell sjukdom, epidemiologi och eventuell smittkälla**
- **Informera patienten om de viktigaste differentialdiagnoserna**
- **Ge hygienråd**

Station 15 Infektion - gastroenterit, 24/04/2024 SKARP 6 min Candidate:

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar reda på detaljer kring aktuella symtom • tidpunkt för debut, duration (1p) • sjukdomssymtom (1p)	2	1	0
Tar viktigaste punkterna i bakgrundsanamnes • Tidigare sjukdomar (0,5p) • Mediciner (0,5p) • Socialt (0,5p) Maximalt 1p erhålles	1	0.5	0
Tar viktigaste punkterna i epidemiologisk anamnes • Andra sjuka i omgivningen/ressällskapet (1p) • Reseanamnes, resmål, längd (1p)	2	1	0
Frågar om smittkälla • Restaurangbesök (0,5p) • Intag av misstänkta livsmedel (0,5p) • Intag av förorenat vatten, egen brunn (0,5p) • Djurkontakt (0,5p)	2	1	0
Adekvata differentialdiagnoser • Viral gastroenterit (0,5p) • Bakteriell gastroenterit ex vis Campylobacterinfektion (0,5p)	1	0.5	0
Ger adekvata hygienråd avseende smitta via hantering av • oförpackade livsmedel (1) • arbete med riskgrupper (spädbarn/gamla) (1)	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 16

En 59-årig lärare kommer till dig på hälsocentralen på grund av minnesbesvär. Han tar inga mediciner, kör inte bil och har inga vapen.

Inför besöket har blodprover tagits (blodstatus, elektrolyter och leverstatus) som alla är normala, samt datortomografi av hjärnan utförts med misstanke om bilateral medial temporallobsatrofi. Mini mental test (MMSE) är 24 av 30p.

Du ska:

- **Ta en riktad anamnes avseende om demenssjukdom föreligger eller inte**
- **Informera patienten om hur du bedömer hans minnesproblem**
- **Föreslå vidare handläggning**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Anamnes avseende minnesproblemen – debut och progression samt påverkan på andra kognitiva förmågor • Tillfredsställande (2p): penetrerar debut och progression, påverkan annan kognition • Delvis tillfredsställande (1p): Delar av debut och progression, påverkan på annan kognition • Ej tillfredsställande (0p): Saknas helt	2	1	0
Anamnes avseende påverkan på ADL-funktion (klara daglig livet, t ex handla mat, räkningar, laga mat, städa, personlig hygien) och nedgång jämfört med tidigare funktionsnivå • Tillfredsställande (2p): Både ADL-funktion och nedgång jämfört med tidigare funktionsnivå • Delvis tillfredsställande (1p): En av ADL-funktion resp nedgång jämfört med tidigare funktionsnivå • Ej tillfredsställande (0p): Saknas helt	2	1	0
Anamnes avseende diff-diagnoser som är viktiga att avgränsa exempelvis depression, alkohol, stress och liknande (”Förklaras inte bättre av andra sjukdomar”) • Tillfredsställande (2p): Berör två differentialdiagnoser • Delvis tillfredsställande (1p): Berör en differentialdiagnos • Ej tillfredsställande (0p): Saknas helt	2	1	0
Studenten förklarar sin bedömning för patienten • Tillfredsställande (2p): Överlämnar bedömning emaptiskt och motiverar sin bedömning • Delvis tillfredsställande (1p): bristfällig bedömning, empati eller motivering • Ej tillfredsställande (0p): Saknas helt	2	1	0
Studenten ger ett adekvat handläggningsförslag • Tillfredsställande (2p): Förklarar remiss till specialistvård (=2 p). Om medicinen erbjuds, förklaras syfte/gör. (Det ska i så fall erbjudas något av acetylkolinesterasläkemedlen) • Delvis tillfredsställande (1p): Ingen remiss till specialistvård. Initierar lämpligt läkemedel dvs acetylkolinesterashämmare (ej Memantin/Ebixa eller ej exemplifierar) • Ej tillfredsställande (0p): Vare sig remiss eller läkemedel eller bristfällig info om vad någon av dessa innebär. • Grav otydlighet (t ex läkarspråk) flyttar ned en poängnivå (2-->1p, 1-->0p)	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 18

Du är jour på akuten. På E4 har det hänt en singelolycka, en älg sprang över vägen. Ambulansen kommer in med en ung kvinna som har varit förare i den bil som voltat.

Du ska:

- **Utföra en strukturerad primär undersökning**
- **Vidta adekvata åtgärder**
- **Sammanfatta din bedömning för en sjuksköterska**

Station 18 AnIVA - Trafikolycka, 24/04/2024 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Presenterar sig för patienten, frågar vad som hänt	0.5	- NA -	0
Airway – identifierar korrekt huruvida det föreligger en fri luftväg	1	- NA -	0
Airway - vill sätta på en halskrage	0.5	- NA -	0
Breathing – identifierar normal andning genom att titta och lyssna	0.5	- NA -	0
Breathing – auskulterar lungor och bekräftar normala andningsljud	0.5	- NA -	0
Breathing – ger patienten syrgas eller tar aktivt ställning på korrekta grunder att det inte behövs	1	- NA -	0
Cirkulation – palperar puls och/eller kopplar pulsoxymetri och bekräftar normal puls/saturation	1	- NA -	0
Cirkulation – tar ett blodtryck och bekräftar ett normalt blodtryck	1	- NA -	0
Disability – tar ett grovt neurologiskt status: medvetandegrad, pupiller, grovmotorik. Bekräftar normala förhållanden.	1	- NA -	0
Sammanfattar att vi har en helt stabil patient	1	- NA -	0
Korrekt ordning på ABCDE-momenten	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10